

**Diretoria de Assistência à Saúde
Diretoria Técnica / Clínica
Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial
Núcleo de Gestão Assistencial**

Nota Orientativa Conjunta nº 01/2022 – SES.DAS / SES.DTE / SES.ENF

Assunto: Realização de Pequenos Procedimentos
na Atenção Primária à Saúde

CONSIDERANDO a Carteira de Serviços da Atenção Primária à Saúde, do Ministério da Saúde, 2020 e o Caderno de Atenção Básica nº 30 de Procedimentos, 2011;

CONSIDERANDO que procedimentos clínicos e cirúrgicos, tais como retirada de nevos, corpos estranhos, cistos e lipomas, cantoplastia, entre outros, também podem ser realizados pelas equipes de Unidades Básicas de Saúde;

CONSIDERANDO que procedimentos clínicos e cirúrgicos aos serem realizados nas Unidades Básicas de Saúde contribuem para o aumento da resolutividade junto à Atenção Primária à Saúde e reduz o estrangulamento dos serviços dos outros níveis de atenção;

A Diretoria de Assistência à Saúde, a Diretoria Técnica/Clínica por meio da Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial e do Núcleo de Gestão Assistencial elaboram e publicam a **Nota Orientativa Conjunta nº 01/2022 – SES.DAS / SES.DTE / SES.ENF**, referente a realização de Pequenos Procedimentos na Atenção Primária à Saúde.

Para a realização de Pequenos Procedimentos na Atenção Primária à Saúde se faz necessário estrutura física adequada:

- ✓ Pia com água para lavagem das mãos;
- ✓ Dispenser de sabonete líquido;
- ✓ Dispenser de papel toalha;
- ✓ Lixeira para descarte de material comum;
- ✓ Lixeira para descarte de material infectante;
- ✓ Caixa de descarte para material perfuro cortante.

Além da estrutura física cada Unidade de Saúde deve possuir também equipamentos, instrumentais, mobiliários, materiais cirúrgicos que fazem parte do elenco básico (apêndice 01), na falta de algum desses itens, deve ser solicitado ao Patrimônio por meio da Central de Serviços <http://centraldeservicos.joinville.sc.gov.br/> e à Central de Abastecimento de Materiais e Equipamentos (CAME).

O profissional da Atenção Primária ao identificar uma condição de saúde em que o grau de traumatismo é pequeno e que ocasiona poucas alterações sistêmicas, poderá realizar pequenos

procedimentos, geralmente realizados sob anestesia local e sem a necessidade de internação, ou seja, a nível ambulatorial.

No momento em que antecede o pequeno procedimento, o usuário deve ser orientado dos riscos e benefícios da realização, por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (apêndice 4), devendo ser impresso duas vias, uma entregue ao usuário e a outra arquivada na Unidade de Saúde.

Com relação ao registro no Prontuário Eletrônico (Sistema Integrado de Gestão – SIG-Saúdetech) é realizado com o código de procedimento **03.01.01.006-4** – Consulta Médica em Atenção Primária, associado ao código do procedimento disponível no apêndice 2.

Modelo de evolução no SIG-Saúdetech

Amostra	Localização	Característica/ Tamanho	Técnica	Hipótese diagnóstica
01	Cervical direita	Nódulo de 2cm	Retirada por PUNCH nº 3 mm	Carcinoma basocelular
01	Cervical posterior	Nódulo de 1cm		
01	Região peitoral	Nódulo de 0,8cm		
Total de amostras: 03				

A solicitação do exame anatomopatológico no Prontuário Eletrônico (Sistema Integrado de Gestão – SIG-Saúdetech) é realizada por meio da Requisição de Procedimentos, código de procedimento **02.03.02.003-0** – Anatomopatológico para Congelamento / Parafina por Peça Cirúrgica ou por Biopsia (Exceto Colo Uterino e Mama).

A identificação do frasco com o material/amostra para o anatomopatológico é realizada com o preenchimento da etiqueta, de forma legível, e que deve ser colada na parte externa do frasco com as seguintes informações:

- ✓ Exame anatomopatológico de;
- ✓ Iniciais do nome do usuário, data de nascimento, matrícula SIG-Saúdetech;
- ✓ Unidade de Saúde;
- ✓ Quantidade de amostras;
- ✓ Data do procedimento;
- ✓ Nome do profissional responsável.

Atenção: A prescrição deve ser encaminhada ao laboratório de diagnóstico anátomo patológico junto com o frasco do material/amostra retirado, conforme Fluxograma 01 (apêndice 3).

Todo material/amostra retirados deve ser encaminhado para exame anátomo patológico com registro em caderno para protocolo do transporte do material/amostra. Os frascos para transporte do material/amostra cirúrgica são fornecidos e retirados no laboratório de diagnóstico

anátomo patológico, que atualmente é o Centro de Diagnósticos Anátomo Patológicos (CEDAP). Os frascos com o material/amostra devem ser encaminhados para o CEDAP, em envelope lacrado, via malote contendo no seu exterior o nome legível da UBSF, conforme Fluxograma 01 (apêndice 3).

Caso o exame anatomopatológico confirmar o diagnóstico de carcinoma, o(a) médico(a) do laboratório de diagnóstico anátomo patológico realizará avaliação imunohistoquímica.

Os laudos dos exames anatomopatológico e/ou imunohistoquímico ficam disponíveis para retirada no laboratório de diagnóstico anátomo patológico, CEDAP, pela equipe da UBSF.

O(a) médico(a) da UBSF registra o resultado do exame em prontuário eletrônico e avalia a necessidade do retorno para entrega do laudo, presencialmente para o usuário.

As orientações e cuidados com a ferida operatória e com o curativo dependem do tipo de lesão e da área operada e devem ser realizadas imediatamente após ao procedimento, sendo importante:

- ✓ Obedecer à prescrição médica;
- ✓ Os pontos serão removidos após 7 a 10 dias, ou conforme orientação médica;
- ✓ Proteger a cicatriz de exposição solar direta por 2 meses;
- ✓ Qualquer sinal de alerta, procurar a UPA/PA 24h.

Para organização de espaço físico e processos de trabalho, sugere-se:

Quadro 1 – Sugestão para composição do “kit para pequenas cirurgias” na Atenção Primária*

- ✓ 20 gazes 7,5 x 7,5;
- ✓ Pinça para assepsia *Pean* 16;
- ✓ 1 tesoura Mayo;
- ✓ 1 pinça Kelly reta;
- ✓ 1 pinça Kelly curva;
- ✓ 1 pinça anatômica;
- ✓ 1 pinça dente de rato;
- ✓ 2 cubas redondas;
- ✓ 1 porta agulha;
- ✓ 1 cabo de bisturi nº 3;
- ✓ 1 tesoura Iris reta;
- ✓ 1 tesoura Iris curva;
- ✓ 1 bandeja pequena.



Quadro 2 – Equipamentos, instrumentais, mobiliários, materiais cirúrgicos disponíveis para compor a Sala de Pequenos Procedimentos

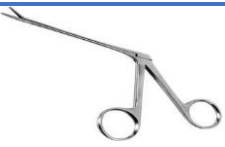
Equipamentos e Mobiliários	Instrumentais e materiais cirúrgicos	Medicamentos / Soluções
✓ Armário vitrine; ✓ Foco de luz com cabo flexível; ✓ Cadeira mocho giratória; ✓ Escada de dois degraus; ✓ Maca; ✓ Mesa acessória com ou sem rodinhas; ✓ Mesa acessória de Mayo.	✓ Eletrocautério; ✓ Campo fenestrado descartável ou de tecido (conforme disponibilidade); ✓ Carpule de anestésico com vasoconstritor; ✓ Seringa 3 ml para anestésico; ✓ Seringa de 20 ml para procedimento de lavagem de ouvido; ✓ Agulha para aplicação do anestésico; ✓ Fios de sutura: • Monofilamento de nylon preto 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0, agulhado de 20 mm ou 25 mm; • Catgut 4,0, agulhado de 20 mm ✓ Material de curativo: • Gaze; • Atadura; • Esparadrapo; • Fita crepe; ✓ Lençóis de pano e/ou descartáveis.	✓ Soluções utilizadas no procedimento sendo: Álcool a 70% para higiene de bancadas e afins; ✓ Soro fisiológico 0,9%; ✓ Ampola de anestésico local (lidocaína); ✓ Clorexidina – Solução Aquosa a 0,02%, Solução Alcoólica a 0,5% e Solução Degermante a 2% para tecido. ✓ Ácido tricloroacético no caso de cauterização química (ATA).
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)		
✓ Avental descartável; ✓ Máscara cirúrgica; ✓ Luva estéril; ✓ Luva de procedimento; ✓ Touca; ✓ Óculos de proteção; e ✓ Calçado fechado.		

REFERÊNCIAS

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Saúde da Família. **Carteira de Serviços da Atenção Primária à Saúde (CaSAPS)**. Versão profissionais de saúde e gestores. Brasília – DF: 2020.
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). **Documento de referência para o Programa Nacional de Segurança do Paciente**. Brasília – DF: 2014.
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). **Resolução – RDC nº 36, de 25 de julho de 2013**. Institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências. Brasília – DF: 2013.
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Procedimentos**. Cadernos de Atenção Básica, nº 30. Brasília – DF: 2011.
5. Organização Mundial da Saúde (OMS). Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Ministério da Saúde (MS). Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). **Segundo desafio global para segurança do paciente: cirurgias seguras salvam vidas**. Rio de Janeiro – RJ: 2010.
6. Prefeitura de Joinville. Secretaria da Saúde. Manual de Biossegurança. Joinville – SC: 2013.



Apêndice 01 – Materiais Cirúrgicos e Instrumentais para Pequenos Procedimentos

	Pinça <i>Halstead</i> Mosquito 10 cm – 65913 12 cm – 65902 • Utilizado para promover a hemostasia por meio da compressão dos vasos		Pinça <i>Kelly</i> Curva 14 cm – 65844 16 cm – 65833 • Utilizada para pinçamento (hemostasia)
	Seringa de Carpule • Utilizado para auxiliar na aplicação de anestesia, sendo bastante utilizada pelos odontólogos		Pinça <i>Allis</i> 15 cm 5x6 dentes – 60238 • Pinça por pressão utilizada em tecidos que serão removidos
	Tesoura <i>Spencer</i> 1 cm • Utilizado para auxiliar na retirada de pontos		Pinça Anatômica Dente de Rato 14 cm – 65967 • Utilizada para segurar e prender tecidos e músculos mais grossos, até mesmo tendões
	Afastador <i>Farabeuf Baby</i> 7x100 mm – 64852 • Utilizados durante procedimentos cirúrgicos que permite ao profissional o "afastamento" das bordas da incisão cirúrgica para melhor exploração		Porta Agulha <i>Mayo Hegar</i> 14 cm com vídea – 65774 • Utilizada para segurar a agulha na sutura de tecidos
	Tesoura <i>Mayo Stille</i> Curva 15 cm – 65651 • Utilizada para desbridar e cortar tecidos mais densos, como fáscia e músculos		Afastador <i>Senn Muller</i> Duplo agudo 16 cm – 64863 • Utilizado para afastar retalhos durante a cirurgia
	Pinça <i>Kocher</i> 16 cm Reta – 65822 • Utilizada na tração de tecido fibroso como aponeurose		Pinça Anatômica de dissecação 14 cm – 65978 • Utilizada em procedimentos hospitalares para manejar, prender ou afastar o tecido e facilitar o uso de outros
	Pinça <i>Hartmann</i> 09 cm para corpo estranho com serrilha – 11080 • Utilizada para retirada de corpo estranho e curativo auricular		Afastador <i>Senn Muller</i> Duplo rombo 16 cm – 64874 • Utilizado para afastar retalhos durante a cirurgia

Continua...

Apêndice 01 – Materiais Cirúrgicos e Instrumentais para Pequenos Procedimentos

	Tentacânula 15 cm sonda acanelada – 60534 • Utilizada para guiar a ponta do escalpelo ou bisturi		Pinça Kelly reta 14 cm – 65854 • Utilizada para pinçamento (hemostasia)
	Pinça Pean 16 cm – 60454 • Utilizada para prender as gazes no procedimento de assepsia		Eletrodo para eletrocautério tipo alça pequena (4,5 mm) ou alça grande (9 mm) – 58361/ 58350
	Pinça Adson com serrilha 12 cm - 65606 • Utilizada em cirurgias plásticas, pediátricas e de cabeça e pescoço por ser delicada		Eletrodo para eletrocautério tipo bola 2,1mm/ 4,2 mm/ 6 mm/ 7,5 mm/ - 58372/ 58383/ 58394/ 58407
	Gancho de Gillies nº 2 delicado – 60206 • Utilizado para manipular tecidos delicados		Eletrodo para eletrocautério tipo faca curva grande ou faca curva pequena – 65990/ 65989
	Pinça Anatômica com videa 12 cm – 65956 • Utilizado para apreensão de tecido com ponta de videa que aumenta a durabilidade da pinça e proporciona uma melhor apreensão do tecido		Eletrodo para eletrocautério tipo faca reta grande 100 mm ou faca reta pequena 67 mm – 58429/ 58430
	Punch dermatológico nº 8 – 60523 • Utilizado para retirar um pedaço da pele ou mucosa para análise patológica, biópsia de pele		Cuba redonda para assepsia 9 cm – 65130



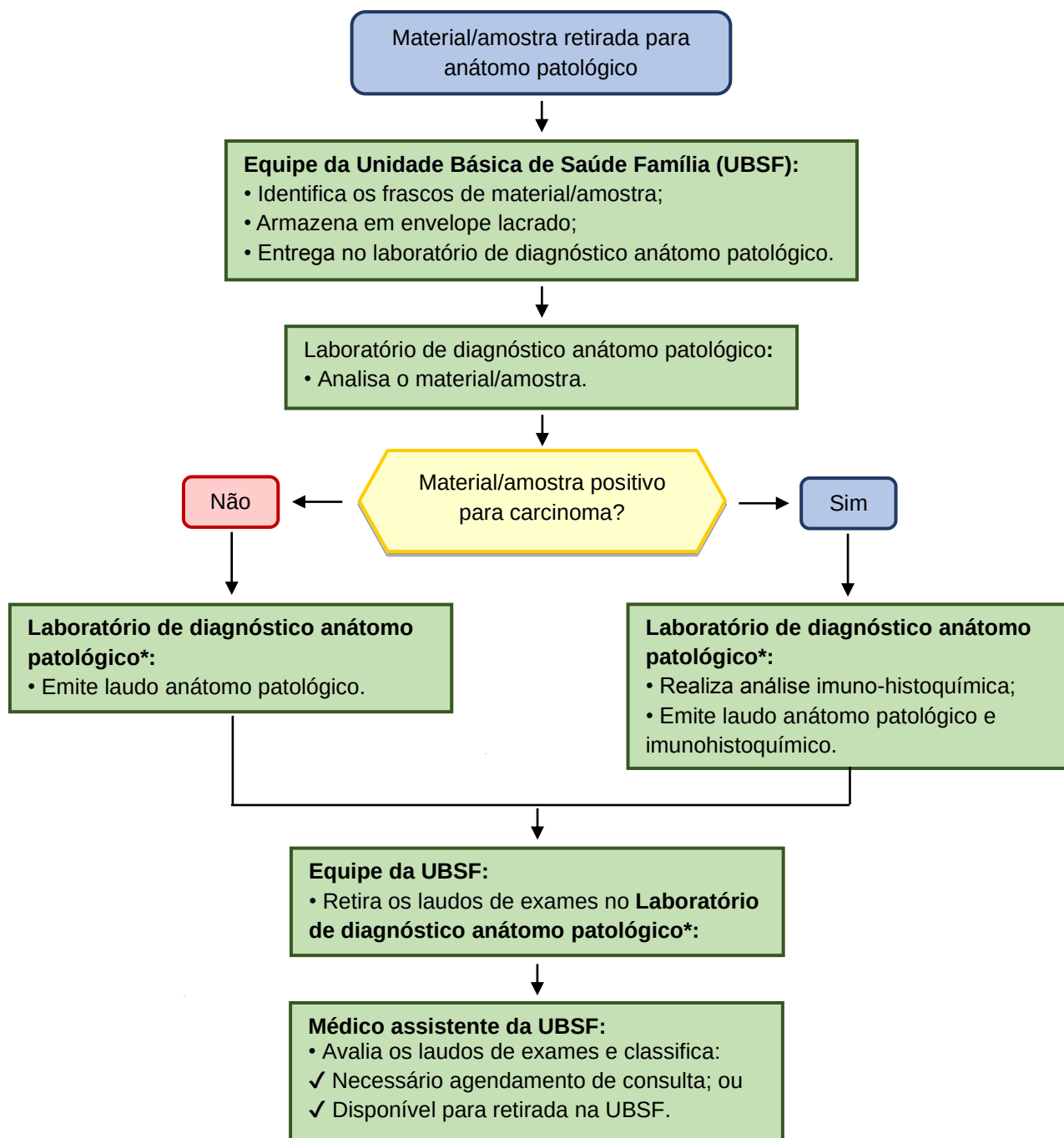
Apêndice 02 – Códigos de procedimentos do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (Tabela Sigtap)

CÓDIGO	PROCEDIMENTO	DESCRIÇÃO
03.03.08.001-9	Cauterização química de pequenas lesões	Consiste na cauterização química de pequenas lesões.
04.01.02.017-7	Cirurgia de unha (cantoplastia)	Consiste no procedimento para a remoção do canto de unha encravada com objetivo de normalizar a arquitetura da área acometida.
04.01.01.001-5	Curativo grau II com ou sem debridamento	Tratamento de lesão aberta, em que há grande área de tecido afetado nos aspectos de extensão, profundidade e exsudato (grau II), com a finalidade de promover cicatrização, evitar contaminação e/ou tratar infecção. Necessitando de cuidados mais complexos.
04.01.01.006-6	Excisão e/ou sutura simples de pequenas lesões / ferimentos de pele / anexos e mucosa	Consiste na retirada cirúrgica onde se faz uma incisão (corte) ao redor ou em qualquer outra forma para retirada da lesão e após parado o sangramento por técnicas cirúrgicas, pode ser realizada ou não a sutura na pele, anexos ou mucosa. O procedimento, também, contempla a realização de suturas simples em ferimentos de pele, anexos ou mucosa.
04.01.01.003-1	Drenagem de abscesso	Consiste em procedimento cirúrgico para promover a drenagem de coleção purulenta na derme e tecido subcutâneo adjacente. Em alguns casos pode ser necessária a colocação de um dreno dentro do espaço deixado pelo abscesso cutâneo para facilitar a drenagem de fluidos corporais.
04.01.01.010-4	Incisão e drenagem de abscesso	Consiste em procedimento cirúrgico para promover a drenagem de coleção purulenta na derme e tecido subcutâneo adjacente. Em alguns casos pode ser necessária a colocação de um dreno dentro do espaço deixado pelo abscesso cutâneo para facilitar a drenagem de fluidos corporais.
04.04.02.005-4	Drenagem de abscesso da boca e anexos	Consiste na realização de drenagem simples da boca e anexos.
04.01.01.007-4	Exérese de tumor de pele e anexos / cisto sebáceo / lipoma registro deve conter CIDS específicos: D170, D171, D172, D173, D177, D179, L720, L721, L728, L729	Consiste na exérese cirúrgica de pequenas lesões de pele e seus anexos, como nevus, cisto sebáceo, incluindo a retirada de cápsula e lipomas, com uso de dreno ou não. Inclui a sutura indicada sendo realizadas em ambulatório.
04.14.02.017-0	Glossorrafia	Consiste na realização de suturas de ferimentos da língua.
04.04.01.027-0	Remoção de cerúmen de conduto auditivo externo. Procedimento uni ou bilateral.	Consiste na remoção de cera dos ouvidos, podendo ser realizada com o uso de aspiradores, curetas, micropinças ou lavagens, indicada quando a presença do cerúmen provoca a sensação de surdez.
04.04.01.030-0	Retirada de corpo estranho da cavidade auditiva e nasal	Consiste na retirada de corpo estranho na cavidade auditiva ou nasal através de técnicas adequadas.
02.03.02.003-0	Anatomopatológico para congelamento / Parafina por peça cirúrgica ou por biopsia (exceto colo uterino e mama)	Consiste no exame macro e microscópico de material obtido por punção por agulha grossa, por biopsia ou por procedimento cirúrgico para diagnóstico definitivo ou tratamento.
02.03.02.004-9	Imunohistoquímica	Exame que permite detecção de antígenos específicos e imunofenotipagem de tecidos.

Fonte: Tabela Sigtap, 2022



Apêndice 03 – Fluxograma de encaminhamento de material/amostra de Anátomo Patológico



Laboratório de diagnóstico anátomo patológico* contratualizado com a SES/Joinville:

- Centro de Diagnósticos Anátomos Patológicos (CEDAP)



Apêndice 04 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Pequenos Procedimentos na Atenção Primária a Saúde

Eu, _____ DN: ____/____/_____,
____ anos, RG _____, Órgão Emissor _____, CPF _____,
Cartão SUS _____, venho por meio deste termo, informar que fui
esclarecido e autorizo a realização do procedimento: _____.

Pelo presente instrumento, declaro que fui suficientemente esclarecido(a) pelo(a) médico(a)
_____ inscrito no CRM/SC sob o nº
_____ a respeito do(s) procedimento(s) acima indicado(s) a que vou submeter-me ou a que será
submetido(a) o(a) paciente do qual sou responsável legal, bem como do diagnóstico, prognóstico, objetivos
do tratamento. Tive a oportunidade de fazer perguntas, as quais foram respondidas satisfatoriamente, em
linguagem compreensível, permitindo o meu adequado entendimento.

Declaro que fui alertado sobre o risco de infecção associado ao procedimento, que devo realizar
higiene no local conforme orientação médica, que fui informado das possíveis complicações decorrentes do
ato cirúrgico e anestésico, tais como: reação às drogas utilizadas, parada cardiorrespiratória, morte,
hemorragias, infecções e que, ao menor sinal de gravidade posteriormente, devo procurar a UPA/UPA 24
horas.

Assim, se a evolução do quadro de saúde representar riscos à vida do paciente, estou ciente de que
serão adotados os procedimentos médicos e hospitalares recomendáveis e necessários, ficando estes desde
já autorizados.

Caso ocorra qualquer uma das situações supracitadas, nenhuma responsabilidade poderá ser
imputada à equipe e/ou instituição que realizou o procedimento, pois o escolhi de minha livre e espontânea
vontade.

Declaro estar ciente de que sou livre para desistir do procedimento a qualquer momento antes do
mesmo e sem prejuízo para meu atendimento.

Declaro também, estar em pleno domínio de minha capacidade civil e de discernimento, autorizando
a realização do procedimento na Atenção Primária à Saúde.

Nome / Assinatura do Usuário/Responsável

Médico – CRM/SC

Joinville, _____ de _____ de 20____.

